

BLOCO 1

0:00 a 2:00

Sobral:

Todos os dias, milhares de pessoas dependem da rede pública de saúde. Mas, antes mesmo de serem atendidas, muitas enfrentam um problema simples: a falta de informação.

Onde devo procurar atendimento? Qual unidade oferece o serviço que eu preciso? Tem profissional disponível? Quanto tempo vou esperar? O medicamento que procuro está disponível?

Muitas vezes, para encontrar essas respostas, o cidadão precisa consultar diferentes canais, entrar em contato com as unidades ou até se deslocar sem saber se vai encontrar o que precisa.

Nas UBSs, isso pode significar dificuldade para consultar serviços, profissionais, horários, agendamentos e medicamentos. Nos pronto-atendimentos, significa escolher uma unidade sem saber previamente como está a demanda ou quanto tempo poderá esperar.

Enquanto isso, a própria rede pública pode ter essas informações distribuídas entre diferentes sistemas e unidades.

Então, o problema não é somente a espera.

É a falta de informação e de previsibilidade durante a jornada do cidadão na saúde pública.

Foi a partir desse problema que surgiu o VITTAS.

BLOCO 2

2:00 a 6:00

Juliana:

O VITTAS é uma plataforma digital que busca integrar informações dos sistemas já utilizados pela rede pública de saúde e apresentá-las de forma simples e acessível para cidadãos, profissionais e gestores.

Nosso foco inicial está nas UBSs e nas UPAs ou Pronto-Atendimentos.

Em vez de criar mais uma fonte isolada de informação, a proposta é reunir e organizar dados que hoje podem estar distribuídos entre diferentes sistemas e unidades.

Mariana:

Nas UBSs, o cidadão poderá encontrar unidades, consultar horários de funcionamento, serviços, profissionais e especialidades disponíveis, além de realizar agendamentos quando o serviço permitir acesso direto.

Também será possível consultar a disponibilidade de medicamentos nas unidades integradas. Como o estoque pode mudar constantemente, o VITTAS mostrará a data e o horário da última atualização, deixando claro que a disponibilidade registrada não representa uma garantia de estoque no momento da chegada.

Nos pronto-atendimentos, a proposta é aumentar a previsibilidade. O cidadão poderá consultar as unidades, os serviços oferecidos, a situação da demanda e, quando houver dados suficientes, uma estimativa do tempo de espera.

Se outra unidade compatível apresentar condições mais favoráveis, o VITTAS poderá recomendá-la. Mas existe um ponto importante: o VITTAS recomenda, o cidadão decide. A plataforma não vai restringir o acesso a uma unidade.

Antes da chegada, o cidadão também poderá fornecer informações iniciais sobre sua necessidade e seus sintomas por meio de uma pré-avaliação orientativa.

Essas informações poderão auxiliar o cidadão e também ser disponibilizadas para a equipe responsável pelo acolhimento e pela triagem.

Nesse ponto existe uma fronteira importante. O VITTAS não realiza diagnóstico e não substitui a classificação de risco feita por um profissional. A classificação, a prioridade e a conduta continuam sob responsabilidade dos profissionais habilitados.

Tiago:

Para a gestão, as informações integradas poderão oferecer uma visão consolidada da demanda, do fluxo de atendimento, dos tempos de espera e de outros indicadores relevantes.

O VITTAS não pretende substituir os sistemas que já sustentam a operação da saúde pública. A proposta é funcionar como uma camada integrada de acesso, acompanhamento, transparência e apoio à gestão.

Para o cidadão, isso significa saber melhor onde ir, o que está disponível e o que esperar.

BLOCO 3

6:00 a 9:00

Samuel:

Embora a experiência para o usuário precise ser simples, por trás dela existe um projeto amplo.

Para tornar essa proposta possível, o VITTAS precisa trabalhar com diferentes módulos e responsabilidades. Temos a identificação dos usuários, unidades e profissionais, agendas e agendamentos, filas e estimativas de espera, medicamentos, notificações, pré-avaliação, indicadores gerenciais e integração com sistemas externos.

Além disso, teremos interfaces com objetivos diferentes. O cidadão precisa de uma experiência simples para encontrar e acompanhar os serviços. Já a gestão precisa visualizar indicadores, demandas e informações operacionais da rede.

E esses módulos precisam se comunicar.

Uma alteração na agenda de um profissional, por exemplo, pode afetar os horários apresentados ao cidadão. As informações de demanda influenciam as estimativas de espera e as recomendações de unidades. Já a disponibilidade de medicamentos depende dos dados recebidos dos sistemas responsáveis pelo estoque.

Ou seja, não estamos falando de várias telas isoladas. Estamos falando de informações e módulos que precisam funcionar em conjunto.

De forma simplificada, os sistemas da rede fornecem as informações, o VITTAS organiza e integra esses dados, e cada perfil recebe aquilo que é relevante para sua necessidade.

O desafio não está apenas em construir telas. Está em integrar diferentes fontes de informação, organizar esses dados, aplicar as regras do negócio e disponibilizar tudo de forma adequada para cada perfil de usuário.

É essa combinação entre integração, diferentes módulos, experiência do usuário e processamento de informações que dá profundidade ao projeto e permite sua evolução ao longo do ano acadêmico.

Lucas:

Nosso escopo inicial permanece delimitado às UBSs e UPAs ou Pronto-Atendimentos.

A expansão para hospitais, exames, cirurgias, internações e outros procedimentos regulados não faz parte do escopo inicial. Ela representa uma evolução futura da proposta.

Nessa evolução, a mesma estrutura poderá permitir que o cidadão acompanhe sua jornada em procedimentos regulados. Quando os sistemas integrados fornecerem dados suficientes, será possível apresentar etapas da solicitação, prioridade, posição na fila, movimentações, pendências e estimativas de atendimento.

Dessa forma, o VITTAS foi pensado não como um sistema que pretende substituir toda a infraestrutura existente, mas como uma solução capaz de integrar, organizar e transformar informações em previsibilidade.

Sobral:

Porque melhorar a experiência na saúde pública não começa apenas quando o cidadão entra no consultório.

Começa quando ele consegue entender onde procurar atendimento, quais recursos estão disponíveis e como será sua jornada até ser atendido.

VITTAS. Mais informação para o cidadão, mais visibilidade para a gestão e mais apoio para quem cuida.